

心理医生报告解读会面

提问清单 · Alex Tang · 临床心理学诊断后续

会面信息

报告编号: Klinisch-psychologisches Gutachten · 2026-05-06

鉴定人: Stephani Campos-Haslehner, MSc.

诊断结论: 注意力缺陷/多动障碍 (ADHS) · ICD-10 F90.0 / ICD-11 6A05.2 混合型

家长陪同: 父母双方

建议预约时长: 60-90 分钟 (普通预约 45 分钟通常不够)

使用说明: 本清单按重要性分为三级 — **A 级 必问** **B 级 建议问** **C 级 时间允许时再问**。每个问题下方留出"医生回答"和"我的下一步行动"两栏, 会面时直接记录。

目录

A 必问问题 (核心 12 问)

- A1. 关于诊断本身
- A2. 关于阿斯伯格 / 自闭症谱系排除
- A3. 关于二语测试和真实智力
- A4. 关于药物 vs 非药物干预
- A5. 关于学校转换的关键问题

B 建议问问题

- B1. 关于"freezing"现象的具体处理
- B2. 关于执行功能脚手架
- B3. 关于情绪和自尊
- B4. 关于父亲的 ADHD 遗传
- B5. 关于多语言环境

C 时间允许时再问

- C1. 长期预后
- C2. 学业路径
- C3. 治疗体系和保险
- C4. 复评和监测

会面前材料清单 · 会面后行动 · 三句话提醒

A 级 · 必问问题（核心 12 问）

A1. 关于诊断本身

A1.1 您给出 ADHD 混合型诊断，但学校老师（TRF/VAD）的评分中"多动/冲动"完全在正常范围，只有家长（CBCL/VAD）评分显示明显多动。在不同情境下表现差异这么大，您是如何理解的？是否考虑过"情境特异性"诊断的可能？

👉 医生回答：

→ 我的下一步：

A1.2 报告里提到学校 "freezing/Einfrieren" 和 "spacing out" 现象——僵直站立、不说话、被点名时僵住。您把这些归为 ADHD 注意问题，但这些症状是否也可能指向：选择性缄默症（Selektiver Mutismus）、焦虑性解离、自闭症 shutdown？您是如何鉴别这些可能性的？

👉 医生回答：

→ 我的下一步：

A1.3 老师在 TRF 中评出 "退缩/抑郁" 和 "思维/睡眠/重复性问题" 异常，"内化性问题" 也异常，这些信号在最终结论里没有展开。您是否认为孩子可能存在共病的焦虑或情绪问题？需要单独评估或干预吗？

👉 医生回答：

→ 我的下一步：

A2. 关于阿斯伯格 / 自闭症谱系的排除

A2.1 AQ 量表中"注意切换"得分位于一般人群第 98.5 百分位，"沟通"位于第 91 百分位，这两项都很高。您把它们解释为 ADHD 的执行功能问题——是否考虑过这也可能是高功能自闭症的部分特征？为什么不进一步做 ADOS-2 这类金标准评估？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A2.2 Alex 有衣物标签的感官敏感、群体中被排斥的迹象、对性别典型角色游戏兴趣低、情绪表达需要支持——这些是否构成做更深入自闭症评估的理由？您建议复评吗？什么时机？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A3. 关于二语测试和真实智力

A3.1 您在报告中说 IQ 117 在母语下可能更高，提示"可能存在天赋异禀"。您在临床上观察到哪些具体表现支持这个判断？您建议什么时候、用什么工具做二次评估（WISC-V 中文版？K-ABC-II？）？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A3.2 如果他被确认为"双重特殊（2e：高智商 + ADHD）"儿童，这会如何改变您的治疗建议？常规 ADHD 干预对 2e 儿童是否需要调整？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A4. 关于药物 vs 非药物干预

A4.1 报告建议"考虑多模态治疗，包括可能的药物支持"。在他这个年龄（8岁）、有"僵住"现象未澄清的情况下，您个人的药物—非药物时序建议是什么？先观察多久？什么信号下应该上药？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A4.2 如果未来上药，常用的 Methylphenidat (Ritalin / Concerta) 在他这种"僵住 + 内化症状"profile 下，会不会加重某些症状？是否有更适合的选择（如 Atomoxetine / Guanfacin）？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A5. 关于学校转换的关键问题

A5.1 9月他将转入奥地利公立小学并留一级。在这个过渡期，"僵住"现象在德语环境下加剧的风险有多大？我们需要做什么具体的预防？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A5.2 我们应该向新学校班主任主动披露什么诊断信息？申请 Nachteilsausgleich 的具体步骤是什么？您能否出具一份给学校的简版诊断说明？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

A5.3 4. Klasse 上半学期分流压力下，Alex 这种 profile 的孩子常见的崩溃信号是什么？我们应该在每天/每周观察什么指标，才能早期发现他撑不住了？

📝 医生回答：

→ 我的下一步：

B 级 · 建议问问题

B1. 关于"freezing"现象的具体处理

B1.1 在治疗师层面，您建议我们找哪类专业人员处理"僵住"现象？儿童行为治疗师（Verhaltenstherapie）、儿童精神科医生、还是心理治疗师（Psychotherapie）？您能推荐 Linz 或周边的具体人选吗？

B1.2 当 Alex 在课堂上"僵住"时，老师当下应该怎么做？应该忽略、轻拍肩膀、还是离开教室？我们和老师怎么训练这套应对？

B1.3 这些"僵住"事件是否会随着年龄增长自然消退？还是必须主动干预？

B2. 关于执行功能脚手架

B2.1 BRIEF 量表显示他的执行功能几乎全面在临床异常范围。在家庭日常中，哪 3 件事是最高优先级的脚手架？

B2.2 您怎么看"先做作业再奖励 30 分钟动画"这种行为契约对他的有效性？还是"分散小奖励"更好？

B2.3 Time Timer / 番茄钟 / 沙漏，哪种时间可视化工具对他这种类型最有效？

B2.4 他写字凌乱（Handschrift unordentlich）—— 这是精细动作问题、视觉空间问题、还是注意力问题？需要 Ergotherapie 介入吗？

B3. 关于情绪和自尊

B3.1 报告提到他说自己"哪都不行"。这种语言对一个 8 岁孩子有多严重？是否到了需要儿童心理治疗的程度？

B3.2 父母在日常对话中应该避免哪类语言？应该多说哪类语言？请给我们 3 条具体的日常语言策略。

B3.3 他对挫折的耐受性低、容易暴怒——这是 ADHD 的一部分还是单独问题？情绪调节有哪些训练方法适合 8 岁孩子？

B4. 关于父亲的 ADHD 遗传

B4.1 父亲在童年期被诊断为 ADHD，这对 Alex 的预后有什么含义？父亲的应对经验能怎么帮上 Alex？

B4.2 弟妹（两个，都更小）将来需要也接受筛查吗？什么年龄做合适？

B5. 关于多语言环境

B5.1 中文（家庭）+ 英语（曾就学）+ 德语（即将就学）的三语环境，对一个 ADHD 儿童的认知负荷有多大？我们应该考虑减少语言数量吗？

B5.2 哪种语言应该是他的“思考语言”？我们如何在家庭中强化这一点？

B5.3 如果他将来在某项学科上挣扎，我们怎么判断这是“语言问题”还是“理解问题”？

C 级 · 时间允许时再问

C1. 长期预后

C1.1 ADHD 在儿童期到青春期的演变曲线如何？哪些症状会消退、哪些会保留、哪些可能加重？

C1.2 高智商 + ADHD 的孩子在成年后的整体功能、职业、人际关系预后如何？有没有什么纵向研究数据可以参考？

C1.3 青春期常见的次生问题（焦虑、抑郁、物质滥用、风险行为）—— Alex 这个 profile 的相对风险有多大？哪些是早期干预能预防的？

C2. 学业路径

C2.1 您见过的 ADHD + 高智商儿童中，AHS（Gymnasium）vs MS/NMS 的实际表现差异是什么？

C2.2 如果他将来确实考不上理想 Gymnasium，转 ORG（高级实科中学）或 BHS 是不是更适合 ADHD 学生的路径？

C2.3 我们看到的"好 Gymnasium"标准（精英、竞争、压力大）—— 这些对他的发展是利大于弊还是相反？

C3. 治疗体系和保险

C3.1 奥地利公立健康保险（ÖGK）在儿童 ADHD 的治疗上覆盖什么？心理治疗、药物、Ergotherapie 哪些是免费/补贴/自费？

C3.2 如果选择私人执业心理治疗师（Wahlpsychotherapie），费用大约多少？保险后报销多少？

C3.3 您本人提供后续治疗吗？还是只做诊断？后续我们应该转给谁？

C4. 复评和监测

C4.1 这次诊断的有效期？多久后建议复评？

C4.2 我们日常应该用什么标准化工具自我监测进度？（CBCL 重测？SDQ？）

C4.3 什么样的进展或退步信号应该立刻联系您？

会面前 · 我们要带的材料

- ☐ 这份提问清单（打印两份）
- ☐ 鉴定报告原件
- ☐ 鉴定报告中文翻译版（如果医生需要给我们解释具体段落）
- ☐ 学校最近的成绩单 / 老师反馈邮件
- ☐ 家庭近期日记 / 行为观察记录（如有）
- ☐ 录音设备（提前征求医生同意——奥地利法律允许在告知后录音自用）
- ☐ 笔记本和两支笔
- ☐ Alex 喜欢的安静活动（如果他要陪同等候）

会面后 · 立刻要做的 5 件事

1. **当晚写一份"会面纪要"**——把医生回答整理成 bullet points，发邮件给伴侣同步
2. **24 小时内决定**：哪些建议立刻执行、哪些观察、哪些拒绝
3. **3 天内**：联系医生推荐的后续专业人员（治疗师、儿童精神科医生）
4. **1 周内**：把医生出具的简版诊断说明递交给新学校

5.2 周内：把这份问题清单的"我的下一步"列填完，转化成行动 checklist

三句话提醒自己

- ◆ **我们是孩子的代言人。**医生再权威，也只在房间里看见孩子 90 分钟；我们看 8 年。我们的观察值钱。
- ◆ **不舒服的问题，更要问。**如果某个回答让我们觉得"她好像没考虑到这个"，那就直接说出来——这是为孩子争取的最后一公里。
- ◆ **不要在会面现场做重大决定。**上药、转学、转治疗师，都回家睡一晚再决定。专业建议是输入，决定是我们的。

文档版本 v1.0 · 2026-05-10 · 为家庭内部使用